

PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN

ANÁLISIS CLÍNICOS – ATENCIÓN PRIMARIA

(v03_Noviembre 2021)

**HOSPITAL REINA SOFIA -
DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA-GUADALQUIVIR**

Con el objeto de mejorar la comunicación entre la UGC de Análisis Clínicos del Hospital Reina Sofía y las distintas UGCs del Distrito Córdoba y Guadalquivir, se ha establecido un grupo de trabajo con profesionales de los dos ámbitos asistenciales, que además de dar respuesta a las incidencias que se generan en la práctica diaria, garantice la mejora en la calidad asistencial en los pacientes.

En este sentido, la elaboración de distintos acuerdos interniveles entre algunas UGC del HURS y la Dirección del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir con la intención de dotar de una mayor capacidad de resolución a la Atención Primaria junto con la elaboración del Catálogo de Pruebas Diagnósticas para Atención Primaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía de Junio de 2018, hace necesario revisar la Cartera de Servicios ofertada con la inclusión de nuevas pruebas diagnósticas.

Para ello, se solicitan las siguientes actuaciones

1.- PARÁMETROS ANALÍTICOS A INCLUIR

- **Péptido natriurético cerebral (NT-proBNP):** Incluido como cartera ampliada con valoración clínica.

Su utilidad está relacionada con el diagnóstico y el pronóstico de la Insuficiencia Cardíaca y su determinación ha demostrado su utilidad clínica en pacientes que consultan en Atención Primaria con síntomas o signos de sospecha de insuficiencia cardíaca, no habiendo demostrado su utilidad en el cribado de personas asintomáticas.

Esta prueba presenta una alta sensibilidad y baja especificidad por lo que un resultado negativo permitiría descartar prácticamente la enfermedad. El nivel recomendado del NT-proBNP para descartar, en atención primaria, la presencia de insuficiencia cardíaca en un paciente con síntomas, es < 125 pg/ml. en menores de 75 años y < 450 pg/ml en mayores de 75.

Su solicitud debería vincularse a un perfil específico de disnea e insuficiencia cardíaca.

- **Vitamina D (25-Hidroxivitamina D):** Incluido como cartera ampliada con valoración clínica.

La determinación de vitamina D no está indicada en el cribado de déficit de vitamina D en población general, y si se recomienda en pacientes con patologías y tratamientos que alteran el metabolismo de la vitamina D como la insuficiencia renal crónica, las enfermedades que cursan con malabsorción, la insuficiencia hepática, la colestasis y la ingesta de determinados fármacos, como antiepilépticos, corticoides, antirretrovirales y rifampicina. Igualmente se consideran factores de riesgo para el déficit de VD: la obesidad, la baja exposición a la luz solar, las personas con piel morena, la

polimedicación en ancianos y la institucionalización en residencias o centros sociosanitarios.

Si bien es cierto que algunos autores postulan que no es necesario la determinación de vitamina D en los grupos de riesgo de déficit de vitamina D, si lo es para determinadas patologías que alteran el metabolismo de la vitamina D al igual que en aquellos casos de tratamientos crónicos con dosis elevadas de Vitamina D mantenidas sin control.

Actualmente vinculado al perfil COVID AP.

Por todo lo anterior, es necesario poder solicitarlo como prueba independiente.

Al estar incluida en Cartera Ampliada con Valoración Clínica, deberá consignarse obligatoriamente en el Juicio Diagnóstico o en el apartado Datos de Interés Analítico de la solicitud (Anexo 1), datos relacionados con la patología en la que se encuadra (tratamiento farmacológico, sospecha de malnutrición o malabsorción, tratamiento crónico con Vitamina D...) estableciéndose en 4 meses el intervalo mínimo para una nueva solicitud.

- **Ferritina:** Incluido como cartera básica dentro del apartado de Bioquímica, Marcadores tumorales y Proteínas y sometido a filtros

La ferritina además de un marcador de alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de ferropenia, es un reactante de fase aguda que puede elevarse en procesos inflamatorios e infecciosos, enfermedad hepática o tumoral.

Actualmente está vinculada a determinados perfiles como Anemia Crónica, COVID AP, Alopecia, Estudio de Anemia y Hemocromatosis, sin embargo, son otros los motivos en los que podría solicitarse la ferritina de forma aislada sin necesidad de obtener otros parámetros no necesarios o marcar varios perfiles para unificar una petición concreta.

En este sentido, síntomas como fatiga, debilidad, alopecia, uñas quebradizas, dolor de cabeza, mareos o vértigos... están relacionados con niveles bajos de ferritina, sin ser necesaria la presencia de anemia para que se produzcan.

Existen diversas situaciones en la consulta de Atención Primaria en las que estaría indicado la solicitud de ferritina no asociada a perfiles como son:

- Valoración de pérdidas sanguíneas crónicas sin anemia, donde la ferritina baja puede ser el primer valor alterado previo a la anemia sintomática.
- Síntomas relacionados con valores bajos de ferritina en pacientes con enfermedades que producen una malabsorción de hierro como la Enfermedad

Celiaca, Enfermedad de Crohn o Colitis ulcerosa o pacientes con cirugía de derivación gástrica.

- Síntomas relacionados con valores bajos de ferritina en pacientes con dietas estrictas (vegetariana o vegana) cada vez más frecuentes en nuestras consultas.

También podemos encontrar niveles altos de ferritina y síntomas relacionados como oscurecimiento de la piel, dolor abdominal, dolor articular o cansancio, por lo que también estaría indicado la solicitud de ferritina asociada a perfiles con sospechas diagnósticas relacionadas con:

- Sospecha de enfermedad hepática o abuso de alcohol
- Dolor abdominal sugestivo de dispepsia sin respuesta a tratamiento.

Por todo lo anterior, es necesario poder solicitarlo como prueba independiente.

Los filtros a aplicar en la petición de ferritina de forma aislada o asociada a perfiles son:

- **No repetir ante un resultado anterior mayor de 60 ng/mL en los últimos dos meses.**
- **Anular las peticiones que no consignen de forma clara e inequívoca en el Juicio Clínico o en apartado de Datos de Interés Analítico información relacionada con la sospecha diagnóstica de alguna de las patologías arriba mencionadas**

- **Anticuerpos antitiroideos:**

Los anticuerpos pueden ser de varios tipos:

- Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (TPO): Pueden estar elevados tanto en hipotiroidismo de causa autoinmune (Enfermedad de Hashimoto) como en hipertiroidismo de causa autoinmune (Enfermedad de Graves).
- Anticuerpos antitiroglobulina (Tg): Elevados en Enfermedad de Hashimoto.
- Anticuerpos antireceptor de la hormona estimulantes del tiroides: Elevados en Enfermedad de Graves.

La utilidad de la determinación de los anticuerpos antitiroideos, además de para conocer la etiología, sirve para hacer una correcta valoración terapéutica en los pacientes con hipotiroidismo subclínico.

En este sentido, **debería elaborarse un procedimiento en cascada que determinase el valor de los anticuerpos antitiroideos** en:

- Pacientes que presenten valores de TSH entre 4.5 y 6.9 mU/L, rango dónde su valor condicionará el inicio o no de tratamiento sustitutivo.
- Pacientes que presenten valores de TSH > 10 mU/L, como parte del diagnóstico etiológico del hipotiroidismo.

En ambos casos, y dado que el valor positivo de los anticuerpos antitiroideos lo son para toda la vida, cuando por el valor de TSH fuese necesario la determinación de anticuerpos, en el caso de que ya se conociese su resultado positivo, se vinculará a la petición original sin necesidad de volver a realizarlos.

2.- CREACIÓN DE PERFILES

La creación de perfiles en laboratorio permite la optimización de las pruebas analíticas, facilitando la identificación de los parámetros básicos para una determinada sospecha diagnóstica y eliminando peticiones innecesarias.

Por ese motivo, y a raíz de los acuerdos interniveles con distintos servicios del HURS se solicita la **creación de los siguientes perfiles**:

- **Perfil Disnea/Insuficiencia Cardíaca**: Hemograma con fórmula y recuento, glucosa, creatinina, sodio, potasio, THS, perfil lipídico, transaminasas y **NT-proBNP**.

Al contener una prueba incluida en la Cartera Ampliada con Valoración Clínica, y dadas las dificultades e incidentes que se producen para la aplicación de los filtros correspondientes sobre el motivo de consulta, se establece que a partir del 1 de noviembre será obligatorio consignar información justificativa de la solicitud en el apartado Datos de Interés Analítico de la solicitud, con independencia del motivo de consulta indicado (Anexo 1).

- **Perfil dispepsia**: Hemograma con fórmula y recuento, glucosa, creatinina, sodio, potasio, transaminasas (ALT y AST), Bilirrubina, enzimas de colestasis (γ GT y Fosfatasa Alcalina) y **ferritina**.

Al contener una prueba con filtros previos, se aplicarán las condiciones referidas en el apartado correspondiente a Ferritina

- **Perfil COVID persistente:** Hemograma con fórmula y recuento, glucosa, creatinina, sodio, potasio, transaminasas (ALT y AST), Creatinquinasa, perfil tiroideo y **ferritina**.

Este perfil se solicitará a pacientes con sospecha de COVID persistente (Ver acuerdos de Neumología y Medicina Interna) previo a la derivación

Al contener una prueba con filtros previos, se aplicarán las condiciones referidas en el apartado correspondiente a Ferritina

Y la modificación **de los siguientes perfiles:**

- **Fallo de medro:** Incluyendo TSH, Ferritina y Vitamina D.

Al contener una prueba incluida en la Cartera Ampliada con Valoración Clínica (Vitamina D) y otra con filtros previos (Ferritina), se aplicarán las condiciones referidas en los apartados correspondientes.

- **Cardiopatía Isquémica/HTA:** Incluyendo la determinación de **Albumina y cociente albumina /creatinina en orina**, como marcador de IRC en pacientes con factores de riesgo.

3.- SOLICITUD DE ESTUDIOS GENÉTICOS

Cada vez son más los pacientes que acuden a las consultas de Atención Primaria solicitando estudios genéticos por indicación de determinadas especialidades hospitalarias, en las que en el transcurso del diagnóstico de una cierta enfermedad en un paciente se considera necesario el estudio genético para familiares de primer o segundo grado.

Este Consejo Genético en pacientes asintomáticos, debe ser valorado por los especialistas en genética que deben determinar, no solo la pertinencia del estudio sino las implicaciones clínicas y/o asistenciales con otras especialidades, y en las que Atención Primaria tiene escaso margen de maniobra.

Con objeto de determinar un procedimiento homogéneo en todo el Distrito Córdoba y Guadalquivir se establece la Teleconsulta como método de comunicación entre Atención Primaria y el Servicio de Genética.

La vía de acceso a través de Teleconsulta será Unidad de Genética (Análisis Clínicos) indicando en el motivo de consulta “Consejo Genético”

En la Teleconsulta se realizará una breve anamnesis con los datos más relevantes (relación familiar con el caso, presencia o no de síntomas relacionados con la enfermedad a estudiar...)



Distrito Córdoba y Guadalquivir
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

y cualquier otro dato que pueda considerarse de interés, **siendo imprescindible en envío de la documentación (informe hospitalario de hospitales públicos del SNS) dónde se indica el estudio genético a familiares. El envío de esta documentación se hará a través de Captura en la propia teleconsulta.**

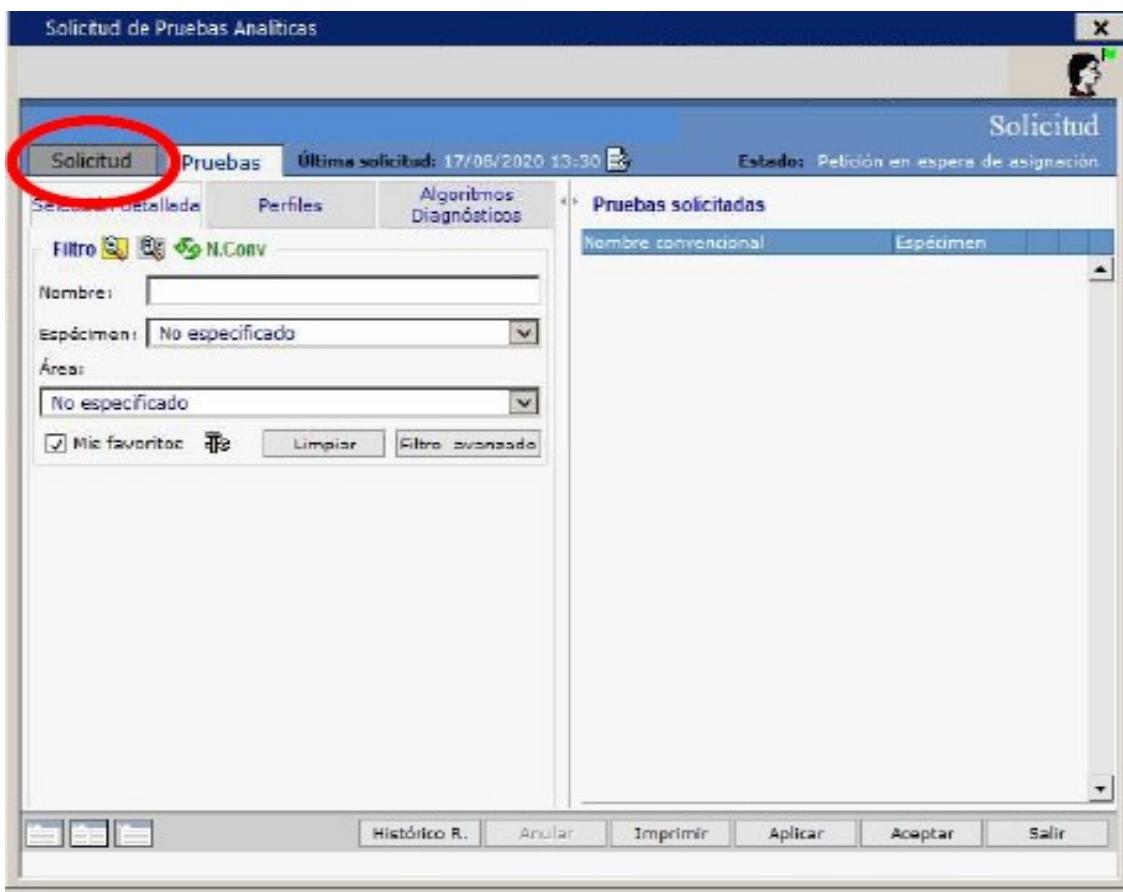
Esta opción estará disponible a partir del próximo 1 de Noviembre de 2021.

ANEXO 1

Cómo incluir información en el apartado de “DATOS DE INTERÉS ANALÍTICO” en la solicitud

Los parámetros incluidos en laboratorio como Cartera Ampliada con valoración clínica en el Catálogo de Pruebas Diagnósticas para Atención Primaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía de Junio de 2018, obliga a la justificación dentro de las sospechas diagnósticas recogidas en este documento.

Para hacerlo, vamos a la pestaña que indica “Solicitud” en la petición analítica



Y a continuación comprobamos el juicio clínico (que lo arrastra de la HSC) y añadimos en texto libre la justificación de la petición de la prueba según los acuerdos adoptados.

Solicitud de Pruebas Analíticas

Solicitud Pruebas Última solicitud: 17/06/2020 13:30 Estado: Petición en espera de asignación

☒ Laboratorio receptor de la unidad Recomendaciones preanalíticas no impresas

Datos Clínicos

Modo: Control Caracter: Rutina

Justificación: CONTROL TRATAMIENTO CRONICO VIT D

Datos de interés analítico

Formato: Texto

Paciente en tratamiento con vitamina D semanal desde hace 1 año

Histórico R. Anular Imprimir Aplicar Aceptar Salir